

## · 科研论著 ·

# 整合怀旧疗法在老年亚临床抑郁妇女中的应用

李芝玉<sup>1</sup>, 冯兰棱<sup>1</sup>, 付月<sup>2</sup>, 陈亚萍<sup>1</sup>, 马秀程<sup>1</sup>, 吴冬梅<sup>1\*</sup>

1.成都市第四人民医院, 四川 610000; 2.成都医学院

## Application of integrated reminiscence therapy in elderly women with subclinical depression

LI Zhiyu<sup>1</sup>, FENG Lanling<sup>1</sup>, FU Yue<sup>2</sup>, CHEN Yaping<sup>1</sup>, MA Xiucheng<sup>1</sup>, WU Dongmei<sup>1\*</sup>

1.The Fourth People's Hospital of Chengdu, Sichuan 610000 China; 2.Chengdu Medical College

\*Corresponding Author WU Dongmei, E-mail: 116969631@qq.com

**Abstract Objective:** To explore the application effect of integrated reminiscence therapy in elderly women with subclinical depression.**Methods:** By using the convenience sampling method, a total of 112 elderly women with subclinical depression who had lived for a long time in a certain city of Sichuan province were selected as the research subjects. They were randomly divided into the intervention group and the control group, 56 cases each. The intervention group received 12-week integrated nostalgia therapy. The control group cases lived as in routine. Before and after the intervention, the Geriatric Depression Scale(GDS), Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), the Reminiscence Functions Scale(RFS), and Ruminative Thought Style Questionnaire(RTS) were used for assessment.**Results:** During the study period, 15 cases dropped out in both the intervention group and the control group. Eventually, each of 41 cases in the intervention group and the control group completed the study. After 12 weeks of intervention, the total score of GDS in the intervention group( $8.76 \pm 5.24$ ) was lower than that in the control group ( $11.66 \pm 5.63$ ). The total score of the CES-D( $10.59 \pm 8.34$ ) was lower than that in the control group( $14.85 \pm 9.25$ ). The total score of RFS( $111.63 \pm 27.51$ ) was higher than that of the control group ( $73.27 \pm 25.06$ ). The differences between the two groups were statistically significant( $P < 0.05$ ). There was statistically significant difference in terms of the RTS score before and after the intervention in the intervention group( $P < 0.05$ ). **Conclusions:** The application of integrated reminiscence therapy could alleviate the depressive symptoms of elderly women with clinical subclinical depression, enhance the nostalgic function. It has potential improvement effect on rumination thinking.**Keywords** integrated reminiscence therapy; subclinical depression; elderly people; nursing

**摘要 目的:**探讨整合怀旧疗法在亚临床抑郁老年女性中的应用效果。**方法:**采用便利抽样法,选取在四川省某市长期居住的亚临床抑郁老年女性112例为研究对象。随机分为干预组和对照组各56例,干预组行12周整合怀旧疗法,对照组常规生活。干预前后采用老年抑郁量表、流调用抑郁自评量表、怀旧功能量表、反刍思维方式问卷进行评估。**结果:**研究期间,干预组、对照组各脱落15例,最终干预组、对照组各41例完成研究。干预12周后,干预组老年抑郁量表总分[( $8.76 \pm 5.24$ )分]低于对照组[( $11.66 \pm 5.63$ )分],流调用抑郁自评量表总分[( $10.59 \pm 8.34$ )分]低于对照组[( $14.85 \pm 9.25$ )分],怀旧功能量表总分[( $111.63 \pm 27.51$ )分]高于对照组[( $73.27 \pm 25.06$ )分],两组比较,差异均有统计学意义( $P < 0.05$ )。干预组干预前后反刍思维方式问卷评分比较差异有统计学意义( $P < 0.05$ )。**结论:**整合怀旧疗法可以缓解临床亚临床抑郁老年女性的抑郁症状,提升怀旧功能,并对反刍思维具有潜在的改善作用。

**关键词** 整合怀旧疗法;亚临床抑郁;老年人;护理

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2025.20.003

亚临床抑郁又称阈下抑郁或症状性抑郁,是指尚未达到抑郁症的诊断标准,但已有抑郁情绪、社会功能

和自我评价降低的亚健康状态<sup>[1-2]</sup>。研究表明,我国老年亚临床抑郁患病率较高,老年抑郁症患病率为2.5%~28.5%<sup>[3]</sup>。随着我国人口老龄化加速,老年人心理问题凸显,尤其是亚临床抑郁,严重影响生活质量,甚至导致自残、自杀<sup>[4-5]</sup>。加强老年人亚临床抑郁的早期干预,预防其发展为抑郁症至关重要,但目前对老年人亚临床抑郁的研究较少。因此,探索有效策略以改善老年人亚临床抑郁,预防其转化为抑郁症,提升

**基金项目** 国家自然科学基金项目,编号:82001444**作者简介** 李芝玉,主管护师,本科**\*通讯作者** 吴冬梅, E-mail: 116969631@qq.com**引用信息** 李芝玉,冯兰棱,付月,等.整合怀旧疗法在老年亚临床抑郁妇女中的应用[J].护理研究,2025,39(20):3392-3398.

心理健康,成为社会各界关注的焦点。怀旧疗法又称回忆疗法或缅怀疗法,1963年由美国精神科医生Butler<sup>[6]</sup>首次提出。通过引导个体回顾过往,旨在改善情绪、提升生活质量,目前逐步发展成为老年护理领域的关键心理干预的方法之一。整合怀旧疗法是一种高度结构化的心理治疗方法,通过设计干预引导参与者回忆生平,整合再评价正负面事件,重塑事件意义,促进自我认同和问题解决。它是一个连续的过程,可融合当下与过去,发现生命的意义,实施者需有相关专业技能,多为心理治疗师<sup>[7-8]</sup>。研究表明,怀旧治疗可改善抑郁症状,提升病人生活质量<sup>[9]</sup>。目前研究中怀旧疗法主要聚焦老年抑郁症病人、轻度认知障碍病人、老年痴呆病人<sup>[10]</sup>、慢性病及癌症病人<sup>[11]</sup>,对亚临床抑郁老年女性的相关研究较少。有研究表明,即使是健康的个体,反刍思维高者更易患抑郁症,女性的反刍思维高于男性<sup>[12]</sup>。基于以上原因,本研究设计了整合怀旧疗法,探索整合怀旧疗法对亚临床抑郁老年女性人群的影响,深入探究此疗法对缓解亚临床抑郁老年女性抑郁症状的效果,并考察其对反刍思维方式的影响,旨在为亚临床抑郁老年女性抑郁症状的干预提供有效的策略与方法,并期望此研究可以为未来的临床实践提供理论依据。

## 1 对象与方法

### 1.1 对象

采用便利抽样法,于2021年1月—2023年12月,选取四川省某市112例老年亚临床抑郁妇女作为研究对象。纳入标准:年龄 $\geq 60$ 岁,女性;在本地区长期居住20年以上;老年抑郁量表(Geriatric Depression Scale, GDS)评分为11~25分(轻度、中度抑郁症状);参与者沟通无障碍,或在视觉、听觉辅助设备帮助下能实现有效沟通;获取参与者的知情同意,自愿参加本调查。排除标准:存在严重躯体疾病,无法承受研究要求者;经简易认知筛查量表评估,认知功能受损者;既往有精神病史或当前正处于精神病发病状态者;正接受抗抑郁药物治疗者;研究期间同时参与其他研究项目者。剔除与脱落标准:纳入后发现不符合纳入条件或未提供任何数据者;因研究相关直接或间接原因(如回忆往事引发的生理或心理不适、抑郁症状加重需转换治疗方式等)退出者,或纳入后需接受其他形式治疗者,视为脱落;已签署知情同意并筛选合格进入干预阶段的受试者,未能完成本研究规定的全部疗程及随访,视为脱落。样本量计算以GDS评分反映被试者抑郁症状变化,采用两组均数比较样本量估算公式: $N =$

$$\left[ \frac{2(u_\alpha + u_\beta)\sigma}{\delta} \right]^2$$

,其中 $N$ 为样本总数,检验水准 $\alpha=0.05$ (双侧), $\beta=0.10$ ,参考相关文献<sup>[13-14]</sup>, $\delta=4$ , $\sigma=5$ ,计算 $N=66$ ,考虑中途退出、失访等,样本量增加20%,总计为80例。本研究已通过电子科技大学伦理委员会审查(审查编号:2020伦审字37号),所有参与者均在充分了解研究内容后,表示知情同意,并签署知情同意书,自愿参与本研究。采用信封随机分组方法,将112例老年亚临床抑郁妇女随机分为干预组和对照组各56例。

### 1.2 干预方法

#### 1.2.1 对照组干预方法

对照组行常规生活,考虑伦理因素,每周至少1次经各种途径为其发放/推送心理健康教育资料,共12周。

#### 1.2.2 干预组干预方法

##### 1.2.2.1 组建研究团队

本研究团队共30名核心成员,包括1名具备博士研究生学历的负责人、2名专职研究助理(均为硕士研究生)、27名资深心理治疗师(均持有心理治疗师证书,并具备10年以上精神科工作经历)。负责人主要组建并领导整个研究团队,开展干预方案讨论会、监督研究过程、质量控制、确保研究质量;2名专职研究助理主要负责数据的收集、分析以及整理工作;27名资深心理治疗师经标准化培训后,负责干预方案的执行与实施。

##### 1.2.2.2 引导物准备

使用老照片作为引导物进行怀旧疗法。通过网站图片搜索功能,从网络获取20世纪50年代初至20世纪90年代末对本地区具有代表意义的照片共879张(如展示当时的工作场景、交通工具、家具家电等照片)。剔除研究者认为照片主体内容不完整、不清晰等不易辨认的照片及有相似图像主体的照片后,剩余331张。通过电脑播放照片,邀请一直居住在本地的7名60~80岁老年女性进行辨认,并对照片进行新旧程度评定和主题判断。在剔除老年人辨认不清楚的照片后(如老年人表示“看不懂”“不知道他在做什么”“这个是干什么的,没见过”“看不清楚”等),形成共228张引导整合怀旧疗法的干预照片库。

##### 1.2.2.3 制订整合怀旧疗法干预方案

干预手册及引导物的准备:以2010年Watt & Cappeliez开发的整合怀旧疗法为蓝本<sup>[15]</sup>,结合负责人前期本土化后的整合怀旧疗法干预手册,制定为期12

周、每周1次、每次约60 min的一对一干预方案,其引导物为老照片。干预主题:以生命回顾的方式进行,包括12个干预主题:我的家乡、童年时光、青春年少、我的第1份工作、年代大事、爱恨的历史、鸾凤和鸣、育儿乐趣、主要的人生转折点、人生成就、执子之手、压力经历以及生活的意义和目标。干预者通过笔记本电脑呈现照片,干预地点在参与者家中。

#### 1.2.2.4 实施干预

每次干预共4部分,并按照以下流程进行:1)寒暄问候(约5 min),主要同参与者问好,确认当前的日期、时间、地点等。2)前奏(约10 min),主要介绍本次活动的主题,逐一向参与者展示当前主题的照片,找出其容易辨认或很感兴趣的照片。3)主体部分(35~45 min),鼓励参与者根据照片内容,叙述由此回忆的情节,重温过去经验,协助其接受过去,体验过去的情感,确认自己的成就,明确自己的能力。引导参与者从不同角度重新认识不快的往事,发掘事情的正负面,开拓自己的想法,并鼓励表达对现实的感受。4)总结(约5 min),复述重要或有趣的片段,总结本次感受,感谢参与,提醒下次时间。运用的心理干预技术包括开放式提问、倾听、重复、沉默、共情、接纳等。

### 1.3 评价工具

#### 1.3.1 一般资料问卷

采用自制问卷调查研究对象的社会人口学资料,主要包括年龄、诊断疾病数量、文化程度、退休前职业、健康情况、居住情况、是否经历亲人去世、居住地、是否吸烟、是否养宠物、每个月可支配金额。

#### 1.3.2 GDS

GDS为专门针对老年人抑郁的评估工具<sup>[16]</sup>,其优势在于排除了可能因年龄增长而伴随的躯体症状条目<sup>[17]</sup>,并采用“是”“否”回答形式。该量表30个条目全面覆盖了老年抑郁的核心症状,包括情绪低落、兴趣丧失、易激惹、焦虑不安以及对过去、现在和未来的消极看法。在计分方式上,10个条目采用反向计分方式(即当回答“否”时计1分),剩余的20个条目则采用正向计分(即当回答“是”时计1分)。该量表总分为0~30分,得分越高,表明抑郁症状越明显。1994年,Chiu等<sup>[18]</sup>将GDS引入我国,并验证了其内部一致性Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.89,重测信度为0.85,与临床诊断标准的一致性效标效度为0.95。该量表在湖南省农村社区老年人群体中的调查结果显示,其内部一致性Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.919<sup>[19]</sup>。GDS因其年龄特异性,可以精确地检测出抑郁症状的动态变化趋势<sup>[20]</sup>,成为评估老年人心理

健康状态的重要工具。经验证此量表在本研究中的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.834,本研究中用作老年抑郁症状的筛检工具及干预措施对抑郁症状作用的效果评价工具。

#### 1.3.3 流调用抑郁自评量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CES-D)

CES-D最初由美国国立精神卫生研究所的Radloff<sup>[21]</sup>编制,是国内外广泛认可的抑郁症状筛查工具,其有效性得到了多项研究的支持<sup>[22]</sup>,量表的Cronbach's  $\alpha$ 系数大于0.80,显示出高度的内部一致性信度<sup>[23]</sup>。该量表包括20个问题,每个问题均针对1个特定的抑郁症状,要求受试者依据过去1周内相关症状的出现频率进行自评,总分为0~60分,得分越高,表明抑郁症状越明显。为了保证应答率,量表不涉及任何个人隐私信息<sup>[23]</sup>。经验证此量表在本研究中的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.877,本研究中用作对抑郁症状作用的效果评价工具。

#### 1.3.4 怀旧功能量表(The Reminiscence Functions Scale, RFS)

RFS用于评估怀旧的功能和频率<sup>[24]</sup>。包括减轻厌烦、死亡准备、自我认同、解决问题、交流沟通、维持亲密、重现痛苦及教育8个方面,共43个条目。其中死亡准备、自我认同、解决问题属于自我积极怀旧,减轻厌烦、维持亲密、重现痛苦属于自我消极怀旧,交流沟通、教育属于亲社会怀旧。各维度评分为其条目评分之和,评分越高,表明该维度的功能作用越强。Webster<sup>[25]</sup>于1997年运用该量表对399名17~45岁人群进行测验,维度内部一致性系数为0.74~0.86。经验证此量表在本研究中的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.957,本研究用于测评整合怀旧疗法对研究对象怀旧功能的影响。

#### 1.3.5 反刍思维方式问卷(Ruminative Thought Style Questionnaire, RTS)

RTS包括20个项目,旨在评估个体在不同情境下反刍思维的风格。此量表各条目按出现的频率,分为1~7级,评分为其条目评分之和,总分为20~140分,评分越高表示反刍思维程度越重。Walsh等<sup>[26]</sup>测内部一致性Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.90。经验证此量表在本研究中的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.935,本研究用于测评整合怀旧疗法对研究对象反刍思维方式的影响。

### 1.4 资料收集与质量控制

本研究采用双盲法控制潜在的偏倚,受试者和所有参与干预的研究人员均不知道具体的分组情况。整个研究遵循干预方案既定流程与目标执行;对研究助

理实施全面培训,确保采用统一标准的问卷指导语与数据记录方法;在干预实施前后的数据收集环节,由 1 名不了解具体干预细节的研究助理负责,旨在获取真实可靠的数据,有效减少因信息偏差带来的影响。研究启动前,对研究团队所有成员进行了统一且系统的培训,培训考核达成一致性后再进行干预,干预过程中进行录音和笔记,并及时对干预过程资料进行评定,以减少信息损失;数据的录入采用双人录入方法,并对数据进行逻辑纠错,确保论文资料收集的准确性与可靠性。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。定性资料用例数、百分比(%)表示,采用 $\chi^2$ 检验。所有连续变量经检验均符合正态分布,以均数±标准差( $\bar{x}\pm s$ )表示,采用  $t$  检验。以  $P<0.05$  为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较

干预组、对照组各有 15 例脱落退出研究,最终两组各 41 例完成研究。两组一般资料比较见表 1。

表 1 两组一般资料比较

Table 1 Comparison of general information between two groups

| 项目          | 分类           | 干预组(n=41)  | 对照组(n=41)  | P     |
|-------------|--------------|------------|------------|-------|
| 年龄(岁)       |              | 68.54±5.25 | 69.41±4.04 | 0.398 |
| 疾病种类(例)     | 无            | 15         | 16         | 0.715 |
|             | 1 种          | 16         | 16         |       |
|             | 2 种          | 5          | 2          |       |
|             | ≥3 种         | 5          | 7          |       |
| 文化程度(例)     | 小学及以下        | 10         | 10         | 0.729 |
|             | 初中           | 14         | 16         |       |
|             | 中专或高中        | 14         | 10         |       |
|             | 专科及以上        | 3          | 5          |       |
| 退休前职业(例)    | 工人           | 13         | 12         | 0.653 |
|             | 农民           | 9          | 11         |       |
|             | 医务人员         | 2          | 4          |       |
|             | 教师           | 4          | 2          |       |
|             | 商人           | 1          | 0          |       |
|             | 行政或管理        | 6          | 9          |       |
|             | 其他           | 6          | 3          |       |
| 健康情况(例)     | 非常差          | 1          | 0          | 0.651 |
|             | 较差           | 6          | 7          |       |
|             | 一般           | 15         | 18         |       |
|             | 良好           | 18         | 16         |       |
|             | 非常好          | 1          | 0          |       |
| 居住情况(例)     | 单独居住         | 6          | 5          | 0.309 |
|             | 与配偶居住        | 14         | 21         |       |
|             | 与成年孩子共同居住    | 11         | 5          |       |
|             | 与配偶及成年孩子共同居住 | 9          | 10         |       |
|             | 其他           | 1          | 0          |       |
| 是否经历亲人去世(例) | 是            | 14         | 9          | 0.219 |
|             | 否            | 27         | 32         |       |
| 居住地(例)      | 城市           | 30         | 38         | 0.051 |
|             | 城镇(乡镇)       | 9          | 3          |       |
|             | 农村           | 2          | 0          |       |
| 是否吸烟(例)     | 是            | 3          | 0          | 0.078 |
|             | 否            | 38         | 41         |       |



(续表)

| 项目          | 分类              | 干预组( $n=41$ ) | 对照组( $n=41$ ) | $P$   |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 是否养宠物(例)    | 是               | 4             | 7             | 0.331 |
|             | 否               | 37            | 34            |       |
| 每个月可支配金额(例) | $\leq 1\,000$ 元 | 3             | 4             | 0.244 |
|             | 1 001~2 000元    | 7             | 7             |       |
|             | 2 001~3 000元    | 7             | 13            |       |
|             | 3 001~4 000元    | 17            | 7             |       |
|             | $>4\,000$ 元     | 7             | 10            |       |

## 2.2 两组 GDS 得分比较(见表 2)

表 2 两组干预前后 GDS 得分比较( $\bar{x}\pm s$ )Table 2 Comparison of the GDS scores before and after intervention between two groups( $\bar{x}\pm s$ ) 单位:分

| 组别    | 例数 | 干预前              | 干预后              | $t$ 值 | $P$      |
|-------|----|------------------|------------------|-------|----------|
| 干预组   | 41 | 14.59 $\pm$ 3.46 | 8.76 $\pm$ 5.24  | 7.054 | $<0.001$ |
| 对照组   | 41 | 14.22 $\pm$ 2.85 | 11.66 $\pm$ 5.63 | 3.430 | 0.001    |
| $t$ 值 |    | 0.523            | -2.417           |       |          |
| $P$   |    | 0.603            | 0.018            |       |          |

## 2.3 两组 CES-D 得分比较(见表 3)

表 3 两组干预前后 CES-D 得分比较( $\bar{x}\pm s$ )Table 3 Comparison of the CES-D scores before and after intervention between two groups( $\bar{x}\pm s$ ) 单位:分

| 组别    | 例数 | 干预前              | 干预后              | $t$ 值 | $P$      |
|-------|----|------------------|------------------|-------|----------|
| 干预组   | 41 | 17.05 $\pm$ 8.16 | 10.59 $\pm$ 8.34 | 5.363 | $<0.001$ |
| 对照组   | 41 | 15.85 $\pm$ 9.28 | 14.85 $\pm$ 9.25 | 1.046 | 0.302    |
| $t$ 值 |    | 0.619            | -2.194           |       |          |
| $P$   |    | 0.538            | 0.031            |       |          |

## 2.4 两组 RFS 得分比较(见表 4)

表 4 两组干预前后 RFS 得分比较( $\bar{x}\pm s$ )Table 4 Comparison of the RFS scores before and after intervention between two groups( $\bar{x}\pm s$ ) 单位:分

| 时间  | 组别    | 例数 | RFS 总分                          | 自我积极怀旧                         | 自我消极怀旧                         | 亲社会怀旧                         |
|-----|-------|----|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 干预前 | 干预组   | 41 | 81.17 $\pm$ 22.01               | 28.27 $\pm$ 11.82              | 33.85 $\pm$ 7.43               | 19.05 $\pm$ 6.43              |
|     | 对照组   | 41 | 81.63 $\pm$ 26.89               | 28.80 $\pm$ 11.38              | 33.00 $\pm$ 11.13              | 19.83 $\pm$ 7.59              |
|     | $t$ 值 |    | -0.850                          | -0.209                         | 0.408                          | -0.502                        |
|     | $P$   |    | 0.932                           | 0.835                          | 0.684                          | 0.617                         |
|     |       |    |                                 |                                |                                |                               |
| 干预后 | 干预组   | 41 | 111.60 $\pm$ 27.51 <sup>①</sup> | 44.44 $\pm$ 12.97 <sup>①</sup> | 40.20 $\pm$ 10.49 <sup>①</sup> | 27.00 $\pm$ 7.43 <sup>①</sup> |
|     | 对照组   | 41 | 73.27 $\pm$ 25.06 <sup>①</sup>  | 26.37 $\pm$ 11.48              | 28.95 $\pm$ 10.14 <sup>①</sup> | 17.95 $\pm$ 6.87              |
|     | $t$ 值 |    | 6.602                           | 6.681                          | 4.936                          | 5.724                         |
|     | $P$   |    | $<0.001$                        | $<0.001$                       | $<0.001$                       | $<0.001$                      |
|     |       |    |                                 |                                |                                |                               |

① 与本组干预前比较, $P<0.05$ 。

2.5 两组 RTS 得分比较(见表 5)

表 5 两组干预前后 RTS 得分比较( $\bar{x}\pm s$ )  
Table 5 Comparison of the RTS scores before and after intervention between two groups( $\bar{x}\pm s$ ) 单位:分

| 组别         | 例数 | 干预前         | 干预后         | <i>t</i> 值 | <i>P</i> |
|------------|----|-------------|-------------|------------|----------|
| 干预组        | 41 | 75.56±24.23 | 60.68±25.34 | 3.280      | 0.002    |
| 对照组        | 41 | 65.66±27.25 | 62.22±29.37 | 0.669      | 0.508    |
| <i>t</i> 值 |    | 1.739       | −0.254      |            |          |
| <i>P</i>   |    | 0.085       | 0.800       |            |          |

3 讨论

3.1 整合怀旧疗法可有效降低老年亚临床抑郁妇女抑郁症状

本研究结果显示,干预 12 周后,干预组 GDS 评分、CES-D 评分均低于对照组( $P<0.05$ ),与童峰等<sup>[27]</sup>研究结果一致。可见,整合怀旧疗法能显著缓解亚临床抑郁老年女性抑郁症状,提升积极情感,减轻消极负担。通过整合怀旧疗法使参与者回忆过去,减轻不良情绪,加深自我了解和价值肯定,从而有效降低参与者抑郁症状。怀旧疗法促使参与者回忆和重新阐释过去的经历,可以分散参与者对消极情绪的关注,从而有效控制不良情绪,增强身心状态的稳定性<sup>[16]</sup>。在怀旧疗法中融入个人感兴趣内容,提升幸福感及积极情感的深度与持久性<sup>[28]</sup>。怀旧疗法简单易行,通过分享老照片等,减轻参与者心理负担<sup>[29]</sup>。

3.2 整合怀旧疗法可提升老年亚临床抑郁妇女的怀旧功能

怀旧并非仅仅是对过往事件的简单追忆,而是一个深刻且结构化的心路历程。通过怀旧,参与者可以重新沉浸并评估自己生活中的过往片段,从中挖掘生活的意义,进而强化自身的适应能力<sup>[30]</sup>。本研究结果显示,干预 12 周后,干预组 RFS 总分及自我积极怀旧维度、亲社会维度评分均高于对照组( $P<0.05$ )。怀旧能储存正面情绪、维持并提升个人主动性、增强社会联系、赋予人存在感以及促进自我统一等<sup>[31]</sup>。可见,怀旧是一种积极的自我资源<sup>[32]</sup>。本研究通过整合怀旧疗法引导老年亚临床抑郁妇女回忆并重新诠释过去的经历,改善其怀旧怀功能,缓解不良情绪,提升自尊和幸福感,从而提高生活质量。在实施整合怀旧过程中,抑郁个体更易消极怀旧<sup>[33]</sup>。有研究指出,负性怀旧功能(如重现痛苦、缓解抑郁)与负性心理呈正相关<sup>[34]</sup>。因此,整合怀旧疗法在提升老年亚临床抑郁妇女怀旧功能时,可能增加消极怀旧风险。提示今后干预应注重引导技巧、治疗环境和个体差异,激发积极怀旧,减少

消极影响。未来研究还需探索优化怀旧疗法的实施方式以提高其疗效和安全性。

3.3 整合怀旧疗法对老年亚临床抑郁妇女的反刍思维具有潜在的改善作用

反刍思维是抑郁症状者常见的消极、自我批评的重复思考模式,涉及沉溺过去、忧虑未来及探寻负面原因与后果<sup>[35]</sup>。与健康的回忆和反思相比,反刍思维具有重复性、情绪消极性以及对自己形象的负面塑造等特点<sup>[36-38]</sup>。作为一种消极的认知模式,反刍思维可以加剧抑郁的风险因素<sup>[39]</sup>。本研究结果显示,干预 12 周后,两组 RTS 评分比较差异无统计学意义( $P>0.05$ ),但干预组评分较干预前明显降低( $P<0.05$ )。提示整合怀旧疗法在一定程度上对亚临床抑郁老年女性的反刍思维具有潜在的改善作用;整合怀旧疗法有助于参与者改变消极的思维模式,减少反刍思维的发生,从而更好地管理负面情绪,有助于情绪的稳定和改善。这一发现为未来研究提供了方向,即进一步探索优化怀旧治疗的方法、增加样本量、延长干预时间等策略,以期提高治疗。

4 小结

本研究结合老年亚临床抑郁妇女人群的独特心理特点,形成整合怀旧疗法,并在老年亚临床抑郁妇女人群中验证应用。该方案由有精神科工作经历的专业心理治疗师严格按照科学、标准化的流程执行,旨在全面探索此疗法对老年亚临床抑郁妇女的影响。研究结果表明,整合怀旧疗法不仅能有效缓解临床老年亚临床抑郁妇女的抑郁症状,还能提升怀旧功能,并对反刍思维具有潜在的改善作用。然而,本研究为单中心研究,受到样本规模相对较小及样本代表性局限的影响。为了进一步提升干预效果,未来的研究可考虑扩大样本范围,涵盖更多元化的人群群体,并开展多中心随机对照干预试验;这将有助于更全面地评估其疗效,为老年亚临床抑郁妇女的心理治疗提供更加坚实的证据支持。

参考文献:

[1] 李丹阳,李琛峰,吴惠雯,等.基于状态的阈下抑郁中医药防治思路探讨[J].中华中医药杂志,2021,36(2):921-923.  
[2] ASSOCIATION A P.Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision(DSM-IV-TR)[M].Arlington, VA:American Psychiatric Association,2000:1.  
[3] 郝小飞,贾玉英,陈洁,等.阈下抑郁症评估工具在老年人中的应用现状[J].中华老年多器官疾病杂志,2024,23(7):553-556.  
[4] 田萌,宋玉磊,张薛晴,等.主观认知下降老年人睡眠分型的潜在剖面分析及其影响因素研究[J].中国全科医学,2023,26(26):3297-3302.  
[5] WANG J L, XU J H, MA Z Y, et al. The mediating role of

- depressive symptoms, hopelessness, and perceived burden on the association between pain intensity and late-life suicide in rural China: a case-control psychological autopsy study[J]. *Frontiers in Psychiatry*, 2021, 12:779178.
- [6] BUTLER R N. The life review: an interpretation of reminiscence in the aged[J]. *Psychiatry*, 1963, 26(1):65-76.
- [7] 樊惠颖, 李峥. 怀旧疗法在老年痴呆患者中的应用进展[J]. *中华护理杂志*, 2014, 49(6):716-720.
- [8] SPIRO N. Music and dementia: observing effects and searching for underlying theories[J]. *Aging & Mental Health*, 2010, 14(8):891.
- [9] 白治繁, 沈军. 怀旧治疗在老年抑郁症中应用研究进展[J]. *护理学报*, 2017, 24(21):28-30.
- [10] 王艳, 段婵芝, 罗洁玲, 等. 国内外回忆疗法研究热点及发展趋势可视化分析[J]. *医学与哲学*, 2024, 45(22):31-36.
- [11] 陈晨, 李贤. 回忆疗法在慢性病人中应用的研究进展[J]. *护理研究*, 2024, 38(20):3654-3658.
- [12] 来水木, 韩秀, 杨宏飞. 国外反刍思维研究综述[J]. *应用心理学*, 2009, 15(1):90-96.
- [13] CHIANG K J, CHU H, CHANG H J, *et al.* The effects of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged[J]. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 2010, 25(4):380-388.
- [14] PINQUART M, FORSTMEIER S. Effects of reminiscence interventions on psychosocial outcomes: a meta-analysis[J]. *Aging & Mental Health*, 2012, 16(5):541-558.
- [15] KARIMI H, DOLATSHAHEE B, MOMENI K, *et al.* Effectiveness of integrative and instrumental reminiscence therapies on depression symptoms reduction in institutionalized older adults: an empirical study[J]. *Aging & Mental Health*, 2010, 14(7):881-887.
- [16] 王丽利, 贾晶晶, 何成丽, 等. 缅怀疗法对老年抑郁症患者抑郁情绪及生活满意度的影响[J]. *护理与康复*, 2020, 19(9):65-67.
- [17] MONTORIO I, IZAL M. The Geriatric Depression Scale: a review of its development and utility[J]. *International Psychogeriatrics*, 1996, 8(1):103-112.
- [18] CHIU H F, LEE H C, WING Y K, *et al.* Reliability, validity and structure of the Chinese Geriatric Depression Scale in a Hong Kong context: a preliminary report[J]. *Singapore Medical Journal*, 1994, 35(5):477-480.
- [19] 何晓燕, 肖水源, 张德杏. 老年抑郁量表在中国农村社区老年人中的信度和效度[J]. *中国临床心理学杂志*, 2008, 16(5):473-475.
- [20] VINKERS D J, GUSSEKLOO J, STEK M L, *et al.* The 15-item Geriatric Depression Scale(GDS-15) detects changes in depressive symptoms after a major negative life event. The Leiden 85-plus study[J]. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 2004, 19(1):80-84.
- [21] RADLOFF L S. The CES-D scale: a self-report depression scale for research in the general population [J]. *Applied Psychological Measurement*, 1977, 1(3):385-401.
- [22] 戴晓阳. 常用心理评估量表手册[M]. 2版. 北京:人民军医出版社, 2015:1.
- [23] 池月云, 杨帆, 王冰娜, 等. 流调用抑郁自评量表在广东省公务员中的信效度分析[J]. *现代预防医学*, 2021, 48(6):969-972.
- [24] 吴捷, 徐晟, 马伟栋, 等. 中国老年人怀旧感量表的编制[J]. *心理与行为研究*, 2019, 17(2):246-252.
- [25] WEBSTER J D. The Reminiscence Functions Scale: a replication [J]. *International Journal of Aging & Human Development*, 1997, 44(2):137-148.
- [26] WALSH E, SHOU Y, HAN J, *et al.* Development and validation of a Chinese language version of the Ruminative Thought Styles Questionnaire[J]. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 2018, 36(6):604-615.
- [27] 童峰, 杨轶, 王娜娜. 回忆疗法对老年人抑郁症状缓解的有效性: 系统评价[J]. *华东理工大学学报(社会科学版)*, 2021, 36(3):46-63.
- [28] 李万明. 怀旧疗法改善独居老年人负面情绪的体验研究与设计 [D]. 北京:北京邮电大学, 2023.
- [29] 吕立召, 王巍, 武倩倩, 等. 怀旧为主题的现实疗法对老年阈下抑郁患者躯体化症状的改善效果[J]. *河北医药*, 2022, 44(18):2864-2867.
- [30] CHEN T J, LI H J, LI J. The effects of reminiscence therapy on depressive symptoms of Chinese elderly: study protocol of a randomized controlled trial[J]. *BMC Psychiatry*, 2012, 12(1):189.
- [31] 薛婧, 黄希庭. 怀旧心理研究述评[J]. *心理科学进展*, 2011, 19(4):608-616.
- [32] VESS M, ARNDT J, ROUTLEDGE C, *et al.* Nostalgia as a resource for the self[J]. *Self and Identity*, 2012, 11(3):273-284.
- [33] MATHEWS A, MACLEOD C. Cognitive approaches to emotion and emotional disorders[J]. *Annual Review of Psychology*, 1994, 45:25-50.
- [34] CULLY J A, LAVOIE D, GFELLER J D. Reminiscence, personality, and psychological functioning in older adults[J]. *The Gerontologist*, 2001, 41(1):89-95.
- [35] 程五一凡, 于东升, 吕东升, 等. 抑郁障碍中反刍思维的研究进展 [J]. *内蒙古医学杂志*, 2024, 56(6):723-725.
- [36] KERTZ S J, PETERSEN D R, STEVENS K T. Cognitive and attentional vulnerability to depression in youth: a review[J]. *Clinical Psychology Review*, 2019, 71:63-77.
- [37] MIHAILOVA S, JOBSON L. The impact of depression and culture on responses to intrusive autobiographical memories: cognitive appraisals, cognitive avoidance, and brooding rumination [J]. *British Journal of Clinical Psychology*, 2020, 59(1):66-79.
- [38] 杨营凯, 刘衍玲. 抑郁反刍的认知神经机制[J]. *心理科学进展*, 2016, 24(7):1042-1049.
- [39] 陈春宇, 连帅磊, 杨晨, 等. 手机成瘾与大学生抑郁的关系: 疲惫感和反刍思维的作用 [J]. *中国临床心理学杂志*, 2019, 27(4):746-749.

(收稿日期: 2025-03-06; 修回日期: 2025-10-09)

(本文编辑 苏琳)